

Conduction (suite) → Bloc de branche

• Ralentissement QRS par atteinte 1 branche faisceau de His

BBB

Bloc de branche Droit = Rythme supraventriculaire (P) et axe électrique normal

• QRS > 120 ms

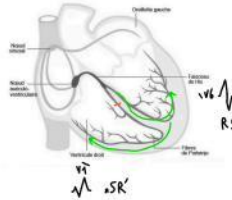
• Aspect mSR' ou RR' en V1



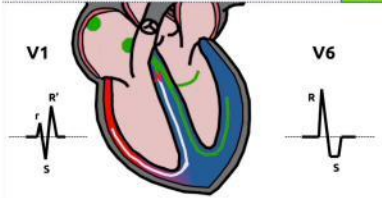
Aspect du QRS en cas de bloc de branche droit complet.

• DI > 50 ms V1

• RS en V5-V6
↑
onde S > 40 ms ou > R



Bloc de branche droit complet (BBB)



BBG complet

déformation VD caché par V6

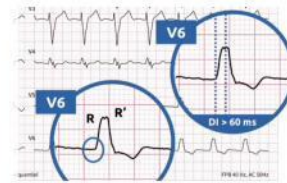
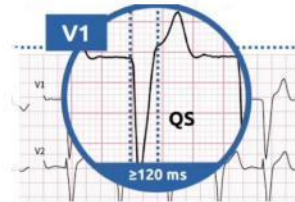


• QRS > 120 ms

• QS en V1 et RR' en V6

• Retard Déflexion Intrinsèque DI > 60 ms V6

• Tr repolarisation



impulse d'excitation QRS

Bloc Fasciculaire Antérieur Gauche (BFAAG)

• Allongement marqué QRS

• Axe QRS vers la gauche

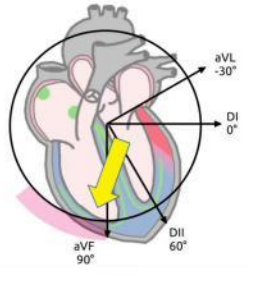
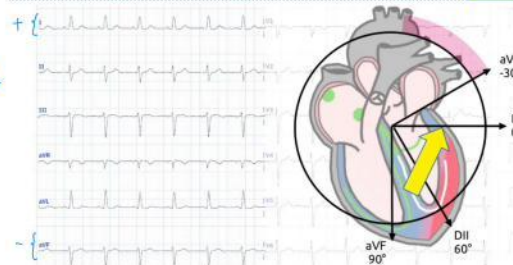
Bloc Fasciculaire Postérieur Gauche (BFPAG)

• Allongement marqué QRS

• Axe vers la droite

Bloc fasciculaire antérieur gauche

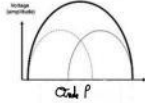
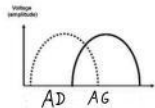
Axe gauche



Hypertrophie

Auriculaire (onde P)

Onde P → dépolarisation atriale
 [Duree < 3 mm = < 120 ms
 Amplitude < 2 mm ≈ 0,2 mV]



Hypertrophie OD
 Amplitude ⊕ mais durée identique
 → D2; D3 (mm)

± V1 = Positif

Hypertrophie OG
 Durée ⊕ mais amplitude etc

→ D1 (mm)
 ± V1 = Biphasique (Positif - négatif) > 4 mm

Ventriculaire (Physiologiquement le VG l'emporte sur le VD :

Droit

• R > S en V1



• S > R en V6



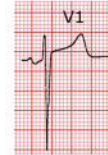
• Axe du QRS dévié à Droite



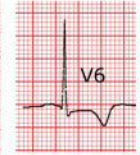
D1 = Axe à droite

Gauche = Augmentation de l'Amplitude physiologique des qRS

• S + + en V1



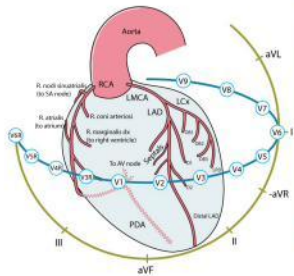
• R + + en V6



Indice Sokolow-Lyon = Amplitude S + Amplitude R > 35 mm

• Déviation qRS Axiale gauche

Ischémie → Les territoires du cœur



Dérivations ST+	Territoire électrique	Artère coronaire
V1 à V3	Septal	IA moyenne (avant 1 ^{re} diagonale)
V3 et V4	Apical	IA moyenne (après 1 ^{re} diagonale)
V1 à V4	Septo-apical (antéro-supérieur)	IA moyenne
V5 et V6	Latéral haut (antérieur moyen)	Circoflexe ou 1 ^{re} diagonale
et/ou RS en V1(V2)	Latéral bas (antéro-latéral)	Circoflexe ou marginale
V1 à V6	Antérieur	IA proximale
V1 à V6 et V8 (D8)	Antérieur étendu	(avant la 1 ^{re} septale) ou TC
V7, V8, V9	Latéro-basal	Circoflexe ou coronaire droite
V1 à V4 et D3-VF-D2	Antéro-inférieur (ou septo-basal)	IA dominante
V3R, V4R, V5R et/ou V1	Ventricule droit	CD ou marginale du bord droit
D3, VF, D2	Inférieur	CD ou circoflexe dominante
D3-VF-D2 + VL-VL ou V5-V6 + V8-V9 ou RS V1	Inféro-latéro-basal	CD ou circoflexe dominante

IA: Interventriculaire antérieure; CD: coronaire droite

Physiologie ST: Phase de plateau de repolarisation

Anomalie ST: ne survient pas à la phase de repolarisation

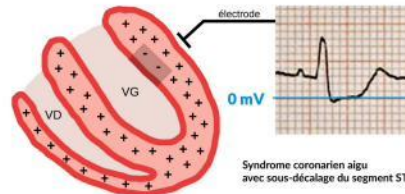
Ischémie: incapable de maintenir le potentiel de repos MBR

Rou: ST précipité / BBG

Cas Ischémie = Artères perforantes par axes vasculaires → PB délit en niveau des

causée Juxta-endothéliale

Obstruction Coronaire Complète = de l'Endocarde à l'Épicarde (Transmural)



Syndrôme coronarien aigu avec sous-décalage du segment ST

Troubles du Rythme Supraventriculaires

Troubles du Rythme Ventriculaires [0. Ventricul = 95% long]

Bradycardie

↳ Sait BAV / Sait plus d'ord P (dysfonction sinuatrial)

↳ Hypovolemie des Atriums, le Nœud Sinuatrial ne contrôle plus l'excitation
 Δ Pas formation de tachycardie → "est-ce que les QRS sautent?"
 • QRS fin!

Échelle = FC Vaut
 Bonnav (TJP) = FC Régulière

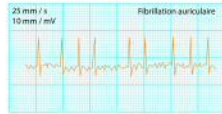
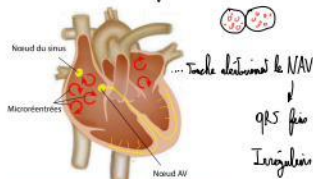
Origine NAV (Type Chaîne)

Excitabilité Atrial / Supraventriculaire

- Onde "P" présente suivie d'un QRS normal
- Temps Refractaire
- Potentiel d'Action Régulier

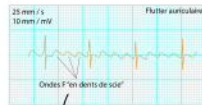
Fibrillation Atrial

- Excitation de la ligne de base



QRS irrégulièrement espacés et oscillation de la ligne de base due à la cavité fibrillaire.

Épisodes Atrial



Can le courant tourne dans l'orbite

- Palpites de contraction (pas altérés)

↳ flutter "typique" = sans anti-hémisphère pour pas l'excitation cardio-tachycardie
 - V6 à inférie (II, III, aVF) ; + V1

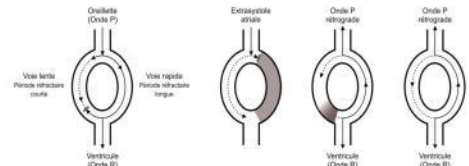
↳ flutter "atypique" = pas pour pas l'excitation cardio-tachycardie
 V6 à V1 en positif

Tachycardie Atrial

- Retour à la ligne isoelectrique. Bat + vite que le NS

Tachycardie Junctionnelle Paroxysmique (mécanisme de Bonnav) TJP

Région Internodale : double NAV



CLASSIQUE

PA → Rapide → qrs
 ↳ Lat

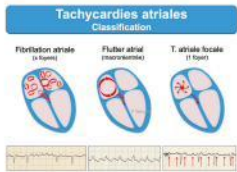
PATOLOGIE

Excitabilité → Rapide → qrs
 ↳ Lat

• Tachycardie Régulière à 180

• Onde P rétrograde

Région Atrio-Ventriculaire (façon de Lat)



Paroxysmique (< 7 jours)

- Asthénie / Dyspnée effort
- Palpites pas anxiété

Paroxysmique (> 7 jours)

↳ Traitement Anti-arythmique

Jeunes Patients → TJP → Tachycardie / Lipid-fébrile / Syncopes

• Massage Sinus Cardiaque

Adénosine (Stimulogène)

• Massage Vagale

• Pression globe oculaire

Tachycardies atrioventriculaires ("tachycardies" paroxysmiques par réentrée)

